

Trzy poziomy *obron*

Od prymitywnych po dojrzałe. Hierarchia Vaillanta to standard dzisiaj — pokazuje, że obron nie konfrontuje się jednakowo: dopasowujesz interwencję do poziomu.

CZAS: 25 min Ocena przy kwalifikacji; formułacja; superwizja

ŹRÓDŁO: Vaillant (1977, 1992); PDM-2 (2017)

JAK UŻYWAĆ

Oceniasz dominujący poziom obron pacjenta i dopasowujesz interwencję. Obrony **dojrzałe** (sublimacja, humor, altruizm) wzmacniasz. **Neurotyczne** (wyparcie, racjonalizacja, intelektualizacja, izolacja afektu) — interpretujesz; to fokus STPP. **Niedojrzałe** (rozszczerzenie, projekcja, odgrywanie, ang. *acting out*) wymagają strukturyzacji i często dłuższej terapii. **Psychotyczne** (zaprzeczenie psychotyczne, zniekształcenie) — nie konfrontujesz; STPP przeciwwskazana.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Traktowanie wszystkich obron jednakowo grozi dekompensacją u poważniejszych pacjentów: konfrontacja obron prymitywnych prowadzi do regresji. Niższe poziomy oznaczają większy deficyt ego. Cel terapii to nie „wyliminować” obrony — są adaptacją, nie słabością — lecz **rozluźnić te sztywne i kosztowne** oraz wspierać rozwój dojrzałych. Przejście od izolacji afektu do humoru i sublimacji jest miarą postępu. Hierarchia nie oznacza „wyższości moralnej”.

01



Piramida dojrzałości obron

4 DOJRZAŁE

sublimacja · humor · altruizm · antycypacja
zdrowe funkcjonowanie — wzmacniaj

3 NEUROTYCZNE

wyparcie · racjonalizacja · intelektualizacja · izolacja afektu · formacja reaktywna
depresja, lęki — fokus STPP, interpretuj

2 NIEDOJRZAŁE

rozszczerzenie · projekcja · odgrywanie · dewaluacja/idealizacja · dysocjacja
rozważ dłuższą terapię — strukturyzuj

1 PSYCHOTYCZNE

zaprzeczenie psychotyczne · projekcja psychotyczna · zniekształcenie
psychoza — STPP przeciwwskazana, ustabilizuj

↑ DOJRZAŁE · PRYMITYWNE ↓

02 Oceń dominujący poziom

Na podstawie obserwacji z sesji 1-3 określ, które obrony przeważają u tego pacjenta. To wpływa na dobór modalności i tempo pracy.

DOMINUJĄCE OBRONY I POZIOM

03 Dopasuj interwencję

Dojrzałe → wzmacniaj. Neurotyczne → interpretuj. Niedojrzałe → strukturyzuj, rozważ dłuższą terapię. Psychotyczne → nie konfrontuj, kieruj na leczenie psychiatryczne.

STRATEGIA DLA TEGO PACJENTA

04 Obserwuj zmianę w czasie

Notuj przesunięcia: czy pojawia się więcej obron dojrzałych? Przejście z izolacji afektu do humoru/sublimacji to postęp terapeutyczny.

ZMIANY W POZIOMIE OBRON

Klucz: obrony są kosztowne, gdy są sztywne. Nawet dojrzałe (humor) mogą blokować afekt, jeśli używa się ich wszędzie. Pytanie kliniczne nie brzmi „która obrona”, lecz: czy obrona służy pacjentowi teraz, czy blokuje jego rozwój?